

机械公司进行追偿；2. 本案事故责任应如何分担。

【法院裁判要旨】

江苏省如东县人民法院经审理认为：基于与受害人顾某近亲属达成的人民调解协议，某车辆装备公司在实际履行协议约定的赔偿义务后有权就其中包含的法定赔偿金额向需要承担侵权责任的某工程机械公司进行追偿。综合考虑某车辆装备公司与某工程机械公司的过错程度，酌定某车辆装备公司对案涉事故承担20%的责任，某工程机械公司承担80%的责任。

江苏省如东县人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国侵权责任法》第六条、第十二条、第十六条、第四十一条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：

一、某工程机械公司于本判决发生法律效力之日起十日内支付某车辆装备公司赔偿款693630.4元；

二、驳回某车辆装备公司的其他诉讼请求。

某工程机械公司不服一审判决，提出上诉。江苏省南通市中级人民法院经审理认为：某车辆装备公司就其履行的赔偿款向某工程机械公司追偿，具有事实和法律依据。一方面，根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第三条第二款的规定，因第三人侵权遭受人身损害的劳动者有权请求侵权的第三人承担民事赔偿责任。可见案涉事故受害人亲属依法享有对某工程机械公司主张人身损害赔偿的权利，该权利不受工伤保险等法律关系的影响。

另一方面，某车辆装备公司在事故发生后与受害人近亲属达成赔偿协议，并履行全部赔偿义务，客观上有利于推动纠纷的实质解决，促进用人单位与工亡职工亲属之间的关系重新回归稳定、有序的状态，对履行人身损害赔偿债务具有合法利益。在某工程机械公司尚未履行赔偿责任的情况下，某车辆装备公司清偿本应由某工程机械公司履行的侵权之债，符合《中华人民共和国民法典》第五百二十四条规定的“第三人代为清偿”的构成要件，受害人近亲属对

某工程机械公司享有的债权依法转让给某车辆装备公司。

综上，某车辆装备公司就其履行的赔偿款向某工程机械公司追偿，具有事实和法律依据。

关于事故责任划分问题。不论是某工程机械公司生产产品不合格的因素，还是某车辆装备公司风险管控和安全管理不到位的因素，均是造成案涉事故的重要原因。缺少其中任何一项因素，事故均不会发生。某车辆装备公司与某工程机械公司应就本案法定赔偿金额各承担50%的赔偿责任。一审判决责任划分明显不当，应予纠正。

江苏省南通市中级人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百二十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第三条、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

一、撤销江苏省如东县人民法院(2023)苏0623民初1366号民事判决；

二、某工程机械公司于收到本判决之日起十日内支付某车辆装备公司赔偿款571247.5元；

三、驳回某车辆装备公司的其他诉讼请求。

【法官后语】

在现实社会生产生活中，侵权法律关系常常涉及多个主体，如在案涉安全生产事故中，涉及用人单位、侵权第三人、受害人三类主体。如果在事故责任确定之前，相关责任主体就受害人的损害赔偿问题相互推诿形成僵局，将不利于受害人权利救济。本案裁判适用第三人代为清偿的规则，承认案涉用人单位

对共同侵权人的追偿权，有助于避免上述僵局的产生，对高效解决相关纠纷具有积极意义。

一、作为介入他人债权债务关系阀门的“合法利益”

基于“任何人不得为他人缔约”的法律原则，只有在第三人同意的前提下，当事人才能为其设定义务。但是，第三人在不负有法定义务时主动代他人

履行债务，情况就大不相同。大部分情况下，第三人代为履行债务有利于债务人，但是第三人毕竟介入了他人的债权债务关系，影响了当事人之间的交易安排与既有秩序，债务人与债权人均有权予以拒绝。在此基础上，当第三人对履行债务不存在利益时，也就不存在承认代为清偿效力的必要性。因此，《中华人民共和国民法典》第五百二十四条第一款规定的第三人代为清偿以其对履行债务具有“合法利益”为前提。

二、从法条文义分析，合法性是对第三人与他人债务利益关联的唯一限定

“合法利益”本就是内涵模糊的不确定概念，从字面含义看，既包括第三人对履行债务可能存在法律上的利益，也包括其他现实利益。《中华人民共和国民法典》第五百二十四条第一款只有“合法”二字起到了限定作用，将行贿等因非法目的而代他人履行债务的情形排除在外，即第三人对履行债务所具有的利益必须是合法的。^①换言之，只要第三人对履行债务享有特殊利益，不论是法律上的利益还是其他事实上的利益，只要不是非法，即满足代为清偿的核心要件。本案中，某车辆装备公司为高效解决人损纠纷，履行其他侵权主体应负的赔偿责任，并无违反法律规定的情形，符合“合法利益”内涵。

三、从利益衡量角度分析，适用第三人代为清偿规则有利于平衡各方利益

通常情况下，只要履行的内容符合当事人的约定，债务人之外的第三人主动履行有利于促进债权及时实现，符合效率价值的要求。客观来讲，承认当事人以外的第三人履行债务或者受领给付，对推动债权实现有所助益。根据本案确立的裁判规则，共同侵权人就其他侵权人应当承担的赔偿义务代为履行后，有权依据民法典有关代为清偿的相关规定，向其他侵权人或实际侵权人进行追偿。本案中适用该规则，不仅符合用人单位的利益需求，及时使得用人单位与受害人亲属之间的关系回归平稳有序状态，且有利于受害人亲属损害赔偿请求权之实现，同时也未损害侵权第三人的合法权益，有效平衡了各方的利益。

编写人：江苏省南通市中级人民法院 谷昔伟 冯禹源 钱荣

^①最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组主编：《中华人民共和国民法典合同编理解与适用（一）》，人民法院出版社2020年版，第422页。

六、医疗损害责任纠纷

25

篡改电子病历的审查与认定

——梁某甲等诉某医院医疗损害责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区高级人民法院(2023)桂民再391号民事判决书

2. 案由：医疗损害责任纠纷

3. 当事人

原告(上诉人、申诉人):梁某甲、梁某乙、吕某、阮某

被告(上诉人、被申诉人):某医院

【基本案情】

患者吕某因产后闭经4年,双眼视力进行性下降3月余,于2015年12月14日入某医院诊治,诊断为鞍上占位性病变、脑积水,经住院治疗后病情无改善并逐渐恶化,吕某于2016年3月2日治疗无效死亡。经鉴定死亡原因为多器官功能衰竭,导致循环血流动力学不稳定,至最终死亡。梁某甲等4人向法院提起医疗损害责任之诉。

在诉讼过程中,梁某甲等4人于2016年6月8日申请进行医疗过错鉴定。

一审法院依法委托某司法鉴定中心就本案中某医院对患者诊疗行为的医疗过错、医疗过错行为与患者死亡的因果关系、过错参与度等专业性问题进行鉴定。某司法鉴定中心《医疗损害鉴定意见书》鉴定结论认为：患者自身疾病的严重性、治疗需要、并发症因素是其脑水肿加重、脑疝形成的根本原因和直接原因，与患者死亡具有直接因果关系，为导致其死亡的主要因素。医方在对患者的诊疗过程中存在对于I级护理的患者，近1周不进行护理记录；堵管前未充分评估患者病情，堵管后缺乏有效观察；未能对转运患者进行有效监护等过错，过错行为导致患者缺氧情况加重，促进病情进展，与患者的死亡有间接因果关系，系导致其死亡的次要因素，建议参与度拟为30%~40%。

梁某甲等4人于2019年4月18日向一审法院申请对患者诊疗过程中的电子病历作电子档形成时间及是否存在改动、改动前内容是什么进行鉴定。经一审法院委托，某司法鉴定所鉴定意见认为：吕某在某医院住院期间的电子病历系统数据有较多的增加和删除的情况，该电子病历数据不真实。

【案件焦点】

1. 应否认定案涉电子病历被篡改；
2. 某医院应承担的民事赔偿责任比例。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院经审理认为：某医院的电子病历在硬件上没有配套使用电子签名系统确保其可靠性，存在难以克服的先天缺陷；在管理上没有依照病历书写规范严格约束，存在难以自圆其说的记录缺失，这与其省级三甲专科医院的应有水平相去甚远。本案病历的公信力及真实性已被动摇，病程记录当中主观病历部分的内容记载已经不具备可靠的真实性，在分析判断时将审慎地进行取舍。鉴定意见已经指出本案电子病历系统数据有较多增加及删除情况，否定了电子病历数据的真实性。某医院的电子病历系统缺少电子签名的功能，可靠性难以保障，究竟何人何时登录系统修改或编辑了病历，目前的在案证据难以反映体现。鉴于有证据证明某医院病历电子数据并不真实可信，而且医方对病历的撰写、编辑瑕疵难以自圆其说，难以排除病历受到篡

改的嫌疑，应推定某医院存在过错。鉴定意见指出的某医院诊疗行为中存在如下诊疗过错：(1) 缺失护理记录；(2) 封堵气管套管前未进行有效评估及有效观察；(3) 转运患者时未依照规范操作等。鉴定意见指出的上述过错均有在案证据证实，予以采纳。综上，推定某医院诊疗行为存在过错，结合患者自身病情特点，酌定患方自行承担40%的责任，即某医院应承担60%的民事赔偿责任为宜。

广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院判决如下：

一、某医院向梁某甲等4人赔偿医疗费、护理费、住院伙食补助费、丧葬费、被扶养人生活费、死亡赔偿金、精神损害抚慰金七项共计765411元；

二、驳回梁某甲等4人的其他诉讼请求。

梁某甲等4人、某医院均不服一审判决，提出上诉。广西壮族自治区南宁市中级人民法院经审理认为：虽然案涉电子病历经鉴定机构依法鉴定，认为存在较多的增加和删除的情况、电子病历数据不真实，但没有证据证实该电子病历中的增加、删除系医方在纸质病历封存之后进行的改动，而医疗机构在制作电子病历过程中进行复制、粘贴、删减系正常的电子数据制作行为，仅以电子病历制作过程中存在改动即认定医方电子病历为伪造、恶意篡改有失公允，故综合全案证据，二审法院认定某医院对梁某甲一方因吕某死亡造成的经济损失承担40%民事赔偿责任，一审判决认定某医院电子病历存在恶意篡改，确定由其承担60%民事赔偿责任依据不足，二审法院不予采信。

广西壮族自治区南宁市中级人民法院判决如下：

一、维持南宁市青秀区人民法院(2016)桂0103民初4571号民事判决第二项；

二、变更南宁市青秀区人民法院(2016)桂0103民初4571号民事判决第一项为：某医院向梁某甲等4人赔偿医疗费、护理费、住院伙食补助费、丧葬费、被扶养人生活费、死亡赔偿金、精神损害抚慰金等，共计407524元。

梁某甲等4人不服二审判决，向检察机关申诉。广西壮族自治区人民检察院提出抗诉。广西壮族自治区高级人民法院再审认为：经鉴定机构对案涉电子

病历进行鉴定，电子病历系统数据有较多增加及删除。某医院电子病历系统未使用电子签名功能，案涉电子病历存在的多处大段增加及删除已无法溯源被增加及删除的原始内容、增加及删除的具体时间及操作人员姓名，且某医院对上述增加及删除行为始终无法作出合理解释，亦未能提供充分证据证实增加及删除的内容与客观情况相符。综上，本案电子病历系统数据有较多被增加及删除已难以排除病历被篡改的可能性，应认定案涉电子病历存在篡改。根据《中华人民共和国侵权责任法》第五十八条“患者有损害，因下列情形之一的，推定医疗机构有过错……（三）伪造、篡改或者销毁病历资料”的规定，一审判决认为应推定某医院存在过错，具有事实和法律依据。参考《医疗损害鉴定意见书》，在本案电子病历系统数据存在较多增加及删除痕迹的情况下，尚能鉴定出某医院的诊疗行为中存在的过错与患者死亡有因果关系，且鉴定意见指出的诊疗行为过错均有在案证据证实，应认定某医院诊疗行为中存在的过错与患者死亡有因果关系。一审法院经综合分析评判患者吕某自身疾病因素，医方诊疗行为的过错程度，酌定患方自行承担40%的责任，某医院承担60%的民事赔偿责任，符合本案客观实际。二审法院直接采信某司法鉴定中心作出的《医疗损害鉴定意见书》中医方过错参与度30%~40%的意见，认定某医院承担40%民事赔偿责任，缺乏全面真实可靠的病历资料作为鉴定基础，依据明显不足，应予以纠正。

广西壮族自治区高级人民法院判决如下：

- 一、撤销南宁市中级人民法院(2021)桂01民终1038号民事判决；
- 二、维持南宁市青秀区人民法院(2016)桂0103民初4571号民事判决第二项；
- 三、变更南宁市青秀区人民法院(2016)桂0103民初4571号民事判决第一项为：某医院向梁某甲等4人赔偿医疗费、护理费、住院伙食补助费、丧葬费、被扶养人生活费、死亡赔偿金、精神损害抚慰金等，共计598396.84元。

【法官后语】

根据《电子病历应用管理规范(试行)》第三条规定：“电子病历是指医

务人员在医疗活动过程中，使用信息系统生成的文字、符号、图表、图形、数字、影像等数字化信息，并能实现存储、管理、传输和重现的医疗记录，是病历的一种记录形式，包括门(急)诊病历和住院病历。”随着信息化的发展和电子信息技术的不断完善，电子病历在医疗领域中得到越来越广泛的应用。随之而来，电子病历也逐渐取代传统的由医务人员亲笔书写的纸质病历，成为医疗损害责任纠纷诉讼中重要的证据基础。

电子病历的修改并不具有传统纸质病历修改的直观性，因而当医患双方产生医疗纠纷时，患方经常因电子病历存在修改、补充等情形对电子病历的真实性提出疑问，主张医方存在篡改电子病历行为。根据《病历书写基本规范》《电子病历应用管理规范(试行)》中的相关规定，在规定的时间内和范围内，按照规定的方式修改电子病历是被允许的。当前医疗领域实务中，在面对患者人数与医疗资源紧张或需要紧急处置的病情时，医务人员为高效推进诊疗行为，在诊疗过程中往往未能一次性完成电子病历的全面准确书写，存在事后补充完善的情况。同时，鉴于电子病历系统本身的电子属性特点，医务人员在使用既有模板或者复制粘贴以往病程记录过程中亦容易出现制作瑕疵，因而需要事后进行核对修改。如果将医方对电子病历的修改轻易认定为篡改，不仅不符合上述关于病历书写与管理的规定，也忽视了电子病历系统本身所具有的特点，容易加重医疗机构的责任，影响医务人员在书写电子病历与高效诊疗行为间的平衡。

在经过对电子病历的鉴定或患方举出相应的证据能够证实电子病历存在修改的情况下，对篡改电子病历的认定应根据案件的具体情况，从以下维度进行严格审查与综合认定。

第一，电子病历的修改是否具有可追溯性。《电子病历应用管理规范(试行)》第六条明确规定，“医疗机构应用电子病历应当……具备对电子病历创建、修改、归档等操作的追溯能力……”第十四条规定：“电子病历系统应当对操作人员进行身份识别，并保存历次操作痕迹，标记操作时间和操作人员信息，并保存历次操作痕迹、标记操作时间和操作人员信息可查询、可追溯。”第十五条规定：“医务人员采用身份标识登录电子病历系统完成书写、审阅、

修改等操作并予以确认后，系统应当显示医务人员姓名及完成时间。”根据上述规定，电子病历的修改时间、修改内容、修改操作人员应具有可追溯性、可查性。本案中，鉴定意见指出案涉电子病历系统未应用电子签名功能，电子病历存在多处、大段的修改且均无法追溯修改时间、修改操作人员及修改前的原始内容，也导致法院对于患方提出的“医方是在患者住院治疗期间因医患双方出现纠纷后马上修改电子病历”的主张无法直观做出判断。某医院对其在电子病历管理方面存在的严重违规导致电子病历的修改丧失可追溯性应承担相应责任。

第二，电子病历的修改目的是否具有正当性。通过审查电子病历修改的背景、时间、内容等来综合判断修改行为是否具有主观恶意，是出于完善病历的目的，抑或为了规避医疗事故责任，掩盖诊疗行为与原始病历的真实内容。如审查修改是否超出允许改动的范围、是否在允许改动的时间内操作、是否增加未真实发生的诊疗行为的记录、是否改变对患者真实用药种类、药量的记录来进行综合判断。

第三，电子病历的修改内容与客观诊疗过程是否具有一致性。一旦电子病历已经证实存在修改，医方应承担举证责任证实其对电子病历的修改与客观实际发生的诊疗过程具有一致性，这一举证责任的分配既与医方作为电子病历的制作方与管理持有方相符，亦与《中华人民共和国民法典》第一千二百二十二条规定的特定情形下对医疗机构采取过错推定原则的精神相契合。本案中，鉴定意见指出案涉电子病历存在多处、大段修改，均无法追溯修改时间与操作人。患方亦提出医方修改电子病历过程中增加的部分治疗内容客观上并未发生。对此，某医院始终未能作出充分合理的解释，未能通过充分举证证实修改后的内容与客观诊疗过程具有一致性。医方应对此承担举证不能的责任。

再审法院结合在案证据从电子病历的修改是否具有可追溯性、电子病历的修改目的是否具有正当性、电子病历的修改内容与客观诊疗过程是否具有一致性等维度出发进行全面审查，合理分配举证责任，经过综合评判认定本案中电子病历存在篡改，并在此基础上结合本案具体情况确定医方应承担的民事赔偿责任。

编写人：广西壮族自治区高级人民法院 郝欣欣

未尸检导致无法鉴定医疗过错是否当然 免除医方的损害赔偿责任

——黄某等诉甲医院、乙医院医疗损害责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区高级人民法院(2023)桂民再125号民事判决书

2. 案由：医疗损害责任纠纷

3. 当事人

原告(上诉人、再审申诉人):黄某、李某1、李某2

被告(被上诉人、再审被申诉人):甲医院、乙医院

【基本案情】

甲医院为乙医院开办的二级医疗机构，不具有独立法人资格。黄某、李某1、李某2是李某某的家属。

李某某因胸闷20分钟，于2017年2月5日20时40分许到甲医院就诊，经急诊检查后，于21时17分入院治疗。收住院后进行了体格检查、血细胞分析检查等。医生进行病情评估：患者考虑冠心病的可能性大，病情随时会出现变化，予以一级护理、心电监护及血氧饱和度监测病情。黄某签署了《预防跌倒/坠床告知书》等，该告知书第二条规定“无论在卧床或下床活动时，应随时有陪伴人员在您的身边”。《患者护理记录单》显示，甲医院于2017年2月5日22时30分开始对李某某进行心电监护及血氧饱和度监测，2017年2月5日22时30分、23时58分和2月6日1时6分、2时5分、11时3分、13时4分、

15时2分、16时5分、17时2分、18时3分、19时均为窦性心律，未见早搏。2017年2月6日10时2分、12时3分、14时2分均为窦性心律，偶见室性早搏。2017年2月6日18时10分，护士巡房，19时30分，护士再次巡房，发现李某某晕倒在地，便立即呼叫其他医护人员进行抢救，2月6日21时6分宣布临床死亡。黄某在《尸检同意书》上签署“不同意尸检”的书面意见。

2017年8月7日，黄某、李某1、李某2向一审法院起诉，要求甲医院、乙医院承担赔偿责任。一审法院作出(2017)桂0108民初2039号民事判决。甲医院不服一审判决提起上诉，二审法院发回重审。重一审中，黄某等人申请医疗过错鉴定，甲医院、乙医院申请医疗事故技术鉴定。经二审法院摇号选取鉴定机构，入围的鉴定机构回函称无法进行医疗过错鉴定，一审法院委托某医学会进行医疗事故技术鉴定。某医学会于2019年6月18日作出《医疗事故技术鉴定书》，分析认为……结论：本病例不属于医疗事故。黄某等人不服该鉴定，提出由司法鉴定机构进行医疗过错鉴定的申请，且未能提供新的证据。

【案件焦点】

未尸检导致无法鉴定医疗过错，是否当然免除医方的损害赔偿责任。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区南宁市良庆区人民法院经审理认为：《医疗事故技术鉴定书》认为甲医院收治李某某入院后的一系列治疗行为及护理均符合诊疗常规，发现李某某晕倒后及时抢救，抢救治疗措施符合临床诊疗常规，甲医院的医疗行为不存在过错。本案中的医疗损害鉴定，程序合法，鉴定意见分析详尽，理由充分，该院予以采纳。根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第七十一条“人民法院委托鉴定部门作出的鉴定结论，当事人没有足以反驳的相反证据和理由的，可以认定其证明力”的规定，黄某等人不服该鉴定，再次提出由司法鉴定机构进行医疗过错鉴定的申请，且未能提供新的证据，缺乏事实和法律依据，该院不予准许。李某某死亡后，因黄某未同意尸检，导致无法查明死因，应自行承担相应的法律后果。

广西壮族自治区南宁市良庆区人民法院判决如下：

驳回黄某、李某1、李某2的诉讼请求。

黄某等人不服一审判决，提出上诉。广西壮族自治区南宁市中级人民法院同意一审法院的裁判理由。

广西壮族自治区南宁市中级人民法院判决如下：

驳回上诉，维持原判。

黄某等人不服二审判决，申请再审。广西壮族自治区高级人民法院经审理认为：患者李某某在甲医院住院治疗期间死亡。一审法院在审理过程中依据双方申请鉴定事项委托某医学会同时进行医疗事故技术鉴定和医疗过错司法鉴定，某医学会回函称无条件进行医疗过错司法鉴定，且超出其鉴定能力范围。后，一审法院移送二审法院摇号选取鉴定机构，但入围的鉴定机构回函称无法进行医疗过错司法鉴定。某医学会根据委托进行了医疗事故技术鉴定，鉴定结论为：医方诊疗行为符合医疗常规，本病例不属于医疗事故。黄某等人主张胸部CT检查材料存在伪造嫌疑，依法不能作为鉴定依据，以及医疗事故技术鉴定书仅加盖某医学会印章，且缺少鉴定依据及使用的科学技术手段、鉴定人鉴定资格的说明和鉴定人员签名三项法定重要内容，不应作为证据采信。《医疗事故技术鉴定暂行办法》第三十五条规定：“医疗事故技术鉴定书应当包括下列主要内容：（一）双方当事人的基本情况及要求；（二）当事人提交的材料和医学会的调查材料；（三）对鉴定过程的说明；（四）医疗行为是否违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规；（五）医疗过失行为与人身损害后果之间是否存在因果关系；（六）医疗过失行为在医疗事故损害后果中的责任程度；（七）医疗事故等级；（八）对医疗事故患者的医疗护理医学建议。经鉴定为医疗事故的，鉴定结论应当包括前款（四）至（八）项内容；经鉴定不属于医疗事故的，应当在鉴定结论中说明理由。医疗事故技术鉴定书格式由中华医学会统一制定。”一审法院委托鉴定前已组织本案双方抽取鉴定专家，并将参加鉴定会的专家签名报到表交与双方核对确认，鉴定所依据的材料亦已组织双方进行了质证，鉴定意见书的格式严格按照上述规定制作。故，某

医学会作出的医疗事故技术鉴定意见书程序合法、鉴定意见分析详尽，理由充分，依法可作为认定本案事实的依据。原审认定医方的诊疗行为不构成医疗事故理据充分，该院予以确认。但是，不构成医疗事故并不必然排除医方的损害赔偿 responsibility。首先，从侵权行为法理论来看，一般侵权行为的构成要件是：违法行为、损害后果、违法行为与损害后果之间存在因果关系、行为人存在主观过错。医疗纠纷本质上属于人身侵权损害赔偿纠纷，适用过错责任原则，认定医疗机构存在侵权行为并不以构成医疗事故为前提，医疗机构承担医疗损害赔偿 responsibility 的原因也可能是医疗事故以外的其他原因。其次，医疗过错鉴定的评判标准和鉴定视角与医疗事故鉴定不同，医疗事故鉴定的评判标准是是否构成“事故”，它倾向认定诊疗行为是否存在过错并由此造成患者人身损害的事故，其鉴定结论主要分析是否达到事故级别，对有过错但不构成事故的情形通常在鉴定结论中不予认定。而医疗过错鉴定的评判标准是是否存在“过错”，主要分析损害后果是否存在、诊疗行为是否存在过错、诊疗过错行为与损害事实之间是否存在因果关系的问题，围绕着“损害、过错及二者之间的因果关系”进行分析、判断。

具体到本案中，黄某等人主张甲医院存在临时医嘱单记录不实、对患者李某胸部 CT 检查不及时、未尽到一级护理责任等医疗过错。对此，该院根据双方提交的证据以及查明的事实分析认定如下：(1) 关于黄某等人所主张的临时医嘱单记录不实、对患者李某胸部 CT 检查不及时的问题。甲医院对此解释为因胸部 CT 检查需送 CT 室进行，送检前需要和 CT 室对接，安排人员及送检，医嘱上的“执行时间”是护士开始着手安排送检相关事宜的时间，因此实际检查时间会出现和执行时间不一致，且李某的病情并未达到急诊做胸部 CT 检查的情况，故医院按照一般流程安排进行胸部 CT 检查，且在李某入院第二天就已安排李某进行胸部 CT 检查，不存在临时医嘱单记录不实和送检不及时的问题。从李某在甲医院急诊科的诊疗情况来看，李某的病情确未达到急诊做胸部 CT 检查的情况。根据一般的检查流程，医方作出医嘱到执行检查，再到检查报告形成，必然存在时间差，所以，甲医院的解释符合常理，予

以采纳。(2)关于甲医院是否尽到一级护理责任的问题。根据《综合医院分级护理指导原则(试行)》第十四条规定,对一级护理患者的护理包括以下要点:(一)每小时巡视患者,观察患者病情变化;(二)根据患者病情,测量生命体征……从甲医院提交的护理单记录来看,甲医院自李某某入院后并未严格做到每小时心电血氧监测。且根据上述规定,甲医院对一级护理患者的护理除需根据患者病情测量生命体征外,还需要每小时巡视患者,观察病情变化,可见遥测心电血氧并不能够替代巡视。甲医院于2017年2月6日18时10分巡房,至当日19时30分才再次巡房,已经超过1小时,在此期间,李某某晕倒在地,经抢救无效死亡。甲医院未能严格执行一级护理要求,导致未能及时发现李某某病情发生变化,最终抢救无效死亡,甲医院对李某某在治疗期间死亡存在一定过错。甲医院主张2014年5月1日实施的中华人民共和国卫生行业标准《护理分级》(WS/T431—2013),并未明确指明一级护理观察患者病情变化的时限,以及其已按照规定对李某某施行每小时遥测心电血氧监测,没有违反相应的护理常规。经查,《综合医院分级护理指导原则(试行)》规定现行有效,2014年5月1日实施的中华人民共和国卫生行业标准《护理分级》(WS/T431—2013)仅是补充和细化了分级标准和依据,使分级护理在临床上更具可操作性和科学性、可行性,并未对《综合医院分级护理指导原则(试行)》规定进行修改,对于一级护理患者须每小时巡视的护理要求仍须执行。故,甲医院提出的上述主张,理由不成立,不予支持。如前所述,甲医院在李某某治疗过程中未能严格执行一级护理要求,导致未能及时发现李某某的病情变化,故李某某的死亡与甲医院的医疗行为不规范存在因果关系,依法应承担相应的责任。

本案经一审法院委托摇号选取鉴定机构,入围机构回函称无法进行医疗过错司法鉴定。因此,甲医院的诊疗行为对李某某死亡的参与度及原因力大小无法通过司法鉴定确定。但是,司法鉴定结论仅是民事诉讼证据的一种,并非认定医院承担民事责任及责任比例的唯一依据,在本案未进行医疗过错司法鉴定且现已不具备鉴定条件的情况下,人民法院结合在案证据综合分析认定医方是否存在过错以及应承担的责任比例。具体到本案中,根据黄某等人提交的李某

某生前的体检报告，李某某并无重大疾病，李某某从入院到死亡未超过48小时，可见病情突然变化系李某某死亡的原因之一。且黄某作为李某某家属，在李某某住院治疗期间未能按照医方要求进行陪护，导致李某某晕倒在地未能及时发现，在李某某死亡后不同意进行尸检，导致李某某死亡原因不明，此亦为本案无法进行医疗过错司法鉴定的重要原因。甲医院虽因未严格执行一级护理“每小时巡视”的要求，对李某某的死亡存在一定过错，但现有证据不能证明该过错行为系导致李某某死亡的直接原因，且在发现李某某晕倒在地后，甲医院积极予以抢救，尽到了医方的救治义务。综上，经综合分析评判患者李某某自身因素以及其家属的过错行为、甲医院诊疗行为的过错程度，酌定由甲医院对黄某等人的损失承担20%的民事赔偿责任。因甲医院不具备对外独立承担民事责任的能力，故本案的赔偿责任由乙医院承担。

关于黄某、李某1、李某2的各项损失计算。经计算，黄某等人的各项损失合计683939.64元，由乙医院根据其过错程度承担20%即136787.93元（683939.64元×20%），再加上精神抚慰金5000元，合计141787.93元。综上，乙医院赔偿黄某等人上述各项费用合计141787.93元。

广西壮族自治区高级人民法院依照《中华人民共和国侵权责任法》第五十四条、第五十七条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第一款及第三款、第十八条第一款、第二十七条、第二十八条、第二十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十四条第一款、第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

一、撤销南宁市中级人民法院（2019）桂01民终14373号民事判决及南宁市良庆区人民法院（2018）桂0108民初1460号民事判决；

二、乙医院于本判决生效之日起十日内赔偿黄某、李某1、李某2各项损失141787.93元；

三、驳回黄某、李某1、李某2的其他诉讼请求。

【法官后语】

由于诊疗行为的专业性、复杂性等原因，对于医疗机构的诊疗行为是否存

在过错的认定，绝大多数时候需要通过司法鉴定来解决，但司法实践中往往不乏无法进行医疗过错鉴定的情形。在医疗机构的诊疗行为是否存在过错鉴定不能时，如何在医方与患方之间找寻平衡点，是司法实践中值得探讨的问题。本案的核心在于，未尸检导致无法进行医疗过错鉴定，是否必然排除医方的损害赔偿责任。

在侵权责任法律中过错责任原则是最基本、最主要的归责原则。关于医疗侵权的归责原则，《中华人民共和国民法典》充分考虑行为本身特点，本着既要保护患者的合法权益，也要保护医院和医务人员的合法权益，有利于医学科学进步以及医药卫生事业发展的考虑，在第五十四条明确规定了医疗损害责任适用过错责任的一般规则。医疗纠纷本质上属于人身侵权损害赔偿纠纷，适用过错责任归责原则，这就意味着医疗机构没有医疗过错就没有责任。从举证责任来看，过错责任原则实行“谁主张，谁举证”。患方主张医疗机构承担诊疗过错赔偿责任，应当提交到该医疗机构就诊、受到损害的证据，至于因果关系、诊疗过错的构成要件事实，可以通过申请鉴定来解决。

司法实践中，往往会出现无法进行医疗过错鉴定的情形，而绝大多数法官缺乏专业的医学知识，难以对医疗机构的诊疗行为是否存在过错作出专业判断，此时应回归侵权责任的构成要件来审查。而且，应正确把握鉴定意见的证据属性及功能。鉴定意见的证明力虽强于一般证据，但其属性仍为《中华人民共和国民事诉讼法》规定的证据类型之一，是否具有证明力及证明力大小需结合证据的形式、来源、内容等进行审核。2012年修正的《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》将“鉴定结论”修改为“鉴定意见”，亦表明司法鉴定仅是司法鉴定人运用专业知识对专门性问题所作的分析和主观判断，其产生的结论并非案件事实判断的最终裁决依据。在审判实务中，法官需结合案件的全部证据对鉴定意见加以综合审查判断，因此，鉴定意见可作为证据，但不是定案的唯一证据。

判断医疗机构是否承担赔偿责任的基本要件，包括违法诊疗行为、患者损害事实、损害与诊疗行为之间存在因果关系和诊疗过错四个要件，四者缺一不

